

Neovejiga ortotópica

WARWIKI

Información para el paciente · Una vejiga nueva, hecha de intestino, por la que usted orina

Una neovejiga ortotópica es una vejiga nueva hecha de un trozo de su propio intestino y conectada a su uretra, para que orine de forma natural — sin bolsa — después de quitar la vejiga o cuando ya no funciona. Aprender a vaciarla bien y recuperar el control toma tiempo y práctica.

Acerca de este procedimiento

Se abren unas **16 a 24 pulgadas de intestino delgado** y se vuelven a doblar en una bolsa de baja presión, conectada a su **uretra**; los uréteres (tubos de los riñones) drenan en ella. **No hay estoma ni bolsa.**

Como la nueva vejiga es de intestino, **no** da la misma señal de “tengo que ir”, así que usted aprende a:

- Vaciar con un **horario** — relajando el suelo pélvico y pujando suave — incluso **despertando de noche**.
- Usar una sonda para drenarla a veces si no se vacía del todo (más común en mujeres).
- Hacer **ejercicios del suelo pélvico** para ganar control.

El control mejora con los **meses**; al inicio es común algo de escape, sobre todo de noche. No todos son candidatos — depende de su uretra, función renal y capacidad de seguir la rutina.

¿Es seguro?

Es una opción bien establecida que da el resultado más “natural”. Es una cirugía mayor y más larga que un conducto, y requiere más aprendizaje y cuidados. Los riesgos incluyen los de cirugía (sangrado, infección, fuga), escape de día o de noche, vaciado incompleto que requiera sonda, moco, infecciones de orina y cambios de sal/vitaminas/riñón a largo plazo, vigilados en el seguimiento.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Neovejiga

Una vejiga nueva hecha de un trozo de intestino.

Ortotópica

Colocada en el sitio normal y unida a la uretra, para orinar de la forma usual.

Uretra

El tubo por el que la orina sale del cuerpo.

Uréteres

Los tubos que llevan la orina de los riñones; drenan en la neovejiga.

Vaciado programado

Orinar con un horario fijo (día y noche) en vez de esperar a la urgencia.

Autocateterismo

Pasar usted mismo un tubo fino para vaciar del todo la neovejiga cuando haga falta.

Suelo pélvico

Los músculos que entrena para ayudar a retener y soltar la orina.

Moco

Líquido resbaloso que hace el intestino; las hebras en la orina son normales.

¿LE DOLERÁ? La cirugía se hace con anestesia general, así que no siente nada durante ella. Después, espere molestia en el vientre, y el intestino tarda unos días en “despertar”. Despierta con una sonda en la nueva vejiga (queda unas 2 a 3 semanas) y catéteres blandos. La mayoría queda en el hospital unos 5 a 8 días; la cirugía es larga.

Cómo prepararse (antes de la cirugía)

- Se hace con **anestesia general** — siga todas las instrucciones (ayuno, suspender anticoagulantes según le digan). Puede tener una **preparación intestinal**.
- Entienda el compromiso: **vaciado programado día y noche**, posible **autocateterismo** y ejercicios del suelo pélvico.
- **No fume**, y organice ayuda en casa después.

Avisé a su equipo con antelación si usted:

- Toma un **anticoagulante** o tiene una infección actual
- Tiene **enfermedad intestinal** o problemas renales, o cirugía abdominal o radiación previas

Qué sucede durante la cirugía

- 1 Está dormido con anestesia y se dan antibióticos.
- 2 Se aparta un trozo de intestino y se reconecta el resto.
- 3 El intestino se abre y se dobla en una bolsa, luego se cose a la uretra.
- 4 Los uréteres se conectan a la bolsa; se colocan una sonda y catéteres blandos mientras cicatriza.

Después de la cirugía

- Va a casa en unos **5 a 8 días** con una **sonda por ~2 a 3 semanas**; puede lavarla para sacar moco.
- Se hace una **radiografía de cicatrización** de la neovejiga antes de retirar la sonda.
- Luego aprende el **vaciado programado** (ponga una alarma de noche), ejercicios del suelo pélvico y **autocateterismo** si no se vacía del todo.
- Espere **escape al inicio** (sobre todo de noche) que mejora con los meses. El moco es normal; tome líquidos; seguimiento de por vida (incl. vitamina B12).

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- **No puede orinar** o la sonda **deja de drenar**
- Dolor fuerte de vientre, vómitos o **no expulsa gases ni heces**
- Sangrado abundante, enrojecimiento o secreción de la herida, o dolor en el costado

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Una neovejiga es una vejiga nueva hecha de intestino y unida a su uretra, para orinar de forma natural sin bolsa.
2. Requiere práctica: vaciado programado día y noche, ejercicios del suelo pélvico y a veces autocateterismo. El control mejora con los meses y el escape inicial es normal.
3. Prepárese siguiendo las instrucciones de ayuno y preparación intestinal y sin fumar. Mantenga la sonda hasta que su equipo la retire tras una radiografía de cicatrización, y llame enseguida si no puede orinar o la sonda deja de drenar.